

SOP KARTE 1: RESPIRATORISCHE NOTFÄLLE

Atemwegs- & Beatmungskrisen | 1:1 AKI-Setting

NOTFALL 1

AKUTE ALARM- UND INDIKATOREN-KASKADE:

- **SpO2-Abfall (< 90 %):** Cyanose, Agitation, Tachypnoe, Schweißausbruch
- **Hochdruckalarm (> 40 mbar):** Kanülenverstopfung, Sekretbolus, Bronchospasmus, Abknicken
- **Niederdruck- / Apnoe-Alarm:** Dislokation, System-Leckage, Diskonnektion, Defekt

Schritt	Handlung / Maßnahme	Fokus / Parameter
1. NOT-BEATMUNG	Beatmebeutel mit O2-Reservoir (15 l/min O2) anschließen. Manuell beateln.	Sichtbare Thoraxhebung. Frequenz 12-15/min. PEEP beachten.
2. ABSAUGEN	Endotracheales Absaugen (max. -0,2 bar). Tiefsaugen starr vermeiden.	Sekretaspekt prüfen (zäh, borkig, blutig). Spülung mit NaCl 0,9%.
3. DISLOKATION	Ungeplantes Herausrutschen: Spreizer/Trousseau ansetzen. Ersatzkanüle einführen.	Gleiche Größe (z.B. Gr. 8) ODER 1 Größe kleiner (Gr. 7) bereithalten.
4. CUFF-DOCK	Cuffdruckprüfer ansetzen. Blockung kontrollieren (Soll: 20-25 mmHg).	Leckageausschluss. Vermeidung von Trachealschleimhaut-Nekrosen.
5. TECHNIK-STROM	Netzausfall: Gerät an Notstromsteckdose (Grün) / Akkubetrieb prüfen.	Ersatzgerät aus Notfallkoffer aktivieren. Hotline Medizintechnik.

NOTFALL-TELEFONKETTE ATEMWEG:

- **Notruf Rettungsdienst:** 112 | • **Notfall-Hotline AERIS (René Krieg):** 0170 / XXX XXX
- **Behandelnder Pneumologe:** 06421 / XXX XXX | • **Medizintechnik 24/7 Hotline:** 0800 / XXX XXX

SOP KARTE 2: KARDIOVASKULÄRE NOTFÄLLE

Reanimation & Medizinische Krisen | 1:1 AKI

NOTFALL 2

PRÜFUNG REANIMATION ZUERST — PATIENTENVERFÜGUNG (§ 1827 BGB):

- **DNR-STATUS PRÜFEN:** Liegt im Klientenstammblatt / Notfallmappe ein gültiger DNR/CPR-Ausschluss vor?
- **FALLS NEIN (Reanimationspflicht):** Sofortige Einleitung CPR (30:2) über Trachealkanüle + Notruf 112.
- **FALLS JA (Palliativ-Status):** Keine Herzdruckmassage. Symptomkontrolle gem. Palliative-Care-Plan.

Indikation	Sofort-SOP	Notfall-Ziel
HERZSTILLSTAND	Prüfe Bewusstsein/Puls. Notruf 112. CPR 30:2 über Kanüle mit O ₂ . Defi anfordern.	ROSC / Überleben sichern.
HYPOTONIE / SCHOCK	RR < 90 mmHg, Puls > 120/min. Flachlagerung, Beine hoch. O ₂ -Gabe erhöhen.	Volumensubstitution n. A.
HYPERTENSIVE KRISE	RR > 180/120 mmHg. Oberkörper hochlagern. Ruhe. Bedarfsmedikation g. Anordnung.	Schlaganfallprävention.
ANAPHYLAXIE / SEPSIS	Fieber/Urtikaria/Stridor. O ₂ max. Notruf 112. Bedarfs-Cortison / Antihistamin.	Allergieschock stoppen.

NOTRUF-SCHEMA (112):

- **WO** ist der Einsatzort? (Adresse des Klienten laut Stammblatt)
- **WAS** ist geschehen? (Invasiv beatmeter Patient, Herzstillstand / Schock)
- **WIE VIELE** Verletzte/Betroffene? (1 Klient)
- **WELCHE** Erkrankung/Vorerkrankung? (ALS/COPD, Tracheostoma, Beatmung)
- **WARTEN** auf Rückfragen des Leitstellendisponenten!

SOP KARTE 3: SCHMERZ & SYMPTOMKRISEN

Pain Nurse & SAPV Palliative Care | § 37b SGB V

PAIN / PALLIATIV

PAIN NURSE & PALLIATIV-ASSESSMENT:

- **Kommunikativer Klient:** NRS-Skala (0 = kein Schmerz, 10 = stärkster unerträglicher Schmerz)
- **Beatmeter / Kognitiv eingeschränkter Klient:** BESD-Skala (Beobachtung von Atmung, Lautäußerung, Gesichtsausdruck, Körpersprache, Tröstbarkeit). Schweregrad ≥ 4 = Akuter Schmerz.

Symptom	Pflegerische Intervention	Medikamentös / Arzt
SCHMERZSTURM	135°-Lagerung, Druckentlastung, Stomakontrolle, ruhige Ansprache.	Bedarfsanalgetikum laut ärztlichem Anordnungsbogen geben. Re-Eval nach 30 Min.
ATEMNOT / PANIK	Atemwegsverlegung ausschließen! Oberkörper hoch. Ruhe ausstrahlen, Frequenz führen.	Morphin-Bedarf / Anxiolytikum (z.B. Tavor) nach Palliativplan verabreichen.
DELIR / AGITATION	Reizabschirmung, Licht dimmen, bekannte Angehörige/Stimme einbinden.	Prüfe Hypoxie/Retention. Arzt / SAPV-Notfalltelefon verständigen.

SAPV- & PALLIATIV-TELEFONKETTE (24/7):

- **SAPV-Palliativteam Hotline:** 06421 / XXX XXX | • **Schmerztherapeut / Hausarzt:** 06461 / XXX XXX
- **Bezugs-Angehörige / Vollmacht:** Laut Stammblatt | • **AERIS Wundberater ICW®:** René Krieg

SOP KARTE 4: PERSONALAUSFALL & KASKADE

1:1 Ausfallmanagement & Standby | § 615 BGB

LOGISTIK 4

VERBLEIBEPFLICHT AM PFLEGE BETT:

- Bei Erkrankung oder Nicht-Erscheinen der Nachfolgekraft darf die Diensthabende Fachkraft das Pflegebett **NIEMALS unversorgt verlassen** (Garantenstellung / § 221 StGB).
- Unverzügliche Aktivierung der 3-stufigen Ausfallkaskade umgehend bei Dienstbeginn-Verzögerung.

Stufe	Akteur / Kaskade	Reaktionszeit / Prozess
STUFE 1	Tandem-Partnerkraft (AERIS)	Unverzügliche Anforderung der eingearbeiteten Vertretungskraft. Übernahme binnen 1-2 Std.
STUFE 2	Angehörigen-Notfallpuffer	Inkubationspuffer (2-4 Std.): Geschulte Angehörige überbrücken Akutphase am Pflegebett.
STUFE 3	AERIS B2B-Springer-Netzwerk	Aktivierung externer Kooperationskräfte / Springer. Benachrichtigung Kostenträger.
KLINIK-FALL	Standby / Vorhaltehonorar	Bei Klinikaufenthalt: 80% Honorar (max. 10 Tage) gem. § 615 BGB. Anrechnung Einnahmen.

AUSFALL-HOTLINES & DISPOSITION:

- Inhaber AERIS (René Krieg): 0170 / XXX XXX | Tandemkraft (René Krieg / Partner): 0171 / XXX XXX
- Angehörigen-Notfallkontakt: Laut Stammblatt | B2B-Springer-Leitstelle: 0800 / XXX XXX